BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN
PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

Số: /BC-PĐD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Giang, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

BÁO CÁO

Rà soát sự cố y khoa năm 2026 và danh sách cần phân tích nguyên nhân gốc (số liệu đến 10/10/2026, đã ẩn thông tin định danh người bệnh)

I. TỔNG HỢP

- Tổng 38 sự cố: Nghiêm trọng 6, Trung bình 5, Nhẹ 19, Chưa gây hại 8.
- Theo nhóm nguyên nhân sơ bộ: có yếu tố điều dưỡng 6; điều dưỡng phối hợp bác sĩ 6; chẩn đoán, chỉ định 17; hành chính, cơ sở vật chất, dược 9.
- Cả 38 sự cố đã ở trạng thái đóng trên phần mềm nhưng chưa có trường nguyên nhân gốc và hành động khắc phục. Đây là điểm trừ chính của tiêu chí A4.2 và cần làm lại theo SOP-A4.2-02.
- Phân nhóm do Phòng Điều dưỡng đề xuất từ tiêu đề và mô tả sự cố, cần nhóm phân tích xác nhận.

II. ƯU TIÊN PHÂN TÍCH

1. 06 sự cố nghiêm trọng: phân tích đầy đủ, chủ trì theo nhóm nguyên nhân (ĐD hoặc KHTH, QLCL).
2. Nhóm nhầm người bệnh, nhầm thông tin (nhiều sự cố cùng loại): một phân tích gộp, giải pháp là chuẩn hóa xác định 2 yếu tố (SOP-A4.2-01).
3. Nhóm chậm báo bác sĩ, chậm phát hiện người bệnh nặng: một phân tích gộp, giải pháp đề xuất là tiêu chí báo động sớm và quy định báo cáo bác sĩ.
4. Các sự cố còn lại: phân tích rút gọn trên BM-A4.2-03.

III. DANH SÁCH SỰ CỐ

STT	Ngày	Khoa	Sự cố (tóm tắt)	Mức độ	Nhóm	Chủ trì phân tích
1	30/01	cchstc	Nhầm thuốc uống giữa hai người bệnh, phát hiện kịp thời	Nhẹ	ĐD	PĐD
2	06/02	cchstc	Nhầm lẫn danh tính giữa hai người bệnh khi hỏi thân nhân xác nhận	Nhẹ	ĐD	PĐD
3	23/02	truyennhiem	Toa thuốc chẩn đoán và điều trị sai tại phòng khám hô hấp	Nghiêm trọng	BS	KHTH (PĐD phối hợp)
4	23/02	truyennhiem	Nhiều lượt khám hô hấp liên tiếp qua các bác sĩ khác nhau, chưa thống nhất chẩn đoán	Nghiêm trọng	BS	KHTH (PĐD phối hợp)
5	23/02	truyennhiem	Toa thuốc chẩn đoán, điều trị sai và chưa xóa mã chẩn đoán cũ tại phòng khám hô hấp	Nghiêm trọng	BS	KHTH (PĐD phối hợp)
6	12/03	khambenh	Chỉ định thiếu xét nghiệm đường huyết cho	Nhẹ	BS	KHTH (PĐD

STT	Ngày	Khoa	Sự cố (tóm tắt)	Mức độ	Nhóm	Chủ trì phân tích
			đoàn khách khám sức khỏe			phối hợp)
7	28/03	khambenh	Sàng lọc mức độ nặng chưa đầy đủ ở người bệnh ngoại kiều, giao tiếp khó khăn	Nghiêm trọng	ĐD+BS	PĐD + KHTH
8	31/03	khambenh	Đăng ký nhầm phòng khám khiến khách hàng chờ lâu	Nhẹ	HC	Đơn vị liên quan
9	05/04	P. CTXH	Nhập sai họ người bệnh khi đăng ký khám	Nhẹ	HC	Đơn vị liên quan
10	17/04	P. CTXH	Đăng ký nhầm chỉ định xét nghiệm cho 2 người bệnh	Nhẹ	HC	Đơn vị liên quan
11	21/04	noitq	Chậm trình bác sĩ đọc điện tim, phát hiện nhồi máu cơ tim muộn	Nghiêm trọng	ĐD+BS	PĐD + KHTH
12	21/04	noitq	Cho y lệnh đo ECG nhưng không kiểm tra kết quả	Trung bình	ĐD+BS	PĐD + KHTH
13	21/04	noitq	Chỉ định nhập khoa chưa phù hợp, người bệnh trở nặng phải chuyển HSCC	Trung bình	BS	KHTH (PĐD phối hợp)
14	21/04	noitq	Xử trí ban đầu chưa phù hợp khi người bệnh trở nặng	Trung bình	BS	KHTH (PĐD phối hợp)
15	21/04	ptgmhs	Bàn mổ số 4 bị kẹt cơ chế nâng hạ	Chưa gây hại	HC	Đơn vị liên quan
16	22/04	khambenh	Nhà vệ sinh phòng tập VLTL thiếu tay vịn, nguy cơ té ngã	Chưa gây hại	HC	Đơn vị liên quan
17	06/05	khambenh	Chưa đo sinh hiệu trước khi chuyển người bệnh đi cận lâm sàng	Chưa gây hại	ĐD	PĐD
18	11/05	khambenh	Nhập viện với vết loét bàn chân, phát hiện nhồi máu cơ tim cấp qua xét nghiệm troponin	Trung bình	BS	KHTH (PĐD phối hợp)
19	18/05	khambenh	Gạch quanh gốc cây bung lên, nguy cơ vấp ngã ở hành lang	Chưa gây hại	HC	Đơn vị liên quan
20	29/05	khambenh	Phân loại bệnh chưa chính xác tại phòng khám	Nhẹ	ĐD+BS	PĐD + KHTH
21	07/06	P. CTXH	Sai mã số CCCD khi đăng ký khám	Nhẹ	HC	Đơn vị liên quan
22	17/06	lienck	Ghi chú hồ sơ chưa đầy đủ trước phẫu thuật mắt, phát hiện muộn kết quả bất thường	Chưa gây hại	BS	KHTH (PĐD phối hợp)
23	23/06	lienck	Chỉ định phẫu thuật cườm sớm hơn quy định sau phẫu thuật mộng thịt	Chưa gây hại	BS	KHTH (PĐD phối hợp)
24	24/06	noitq	Quên báo dịch khi người bệnh lao phổi chuyển tuyến trên	Nhẹ	ĐD+BS	PĐD + KHTH
25	30/06	ngoaitq	Người bệnh đau quặn thận được mời khám và nhập khoa Nội thay vì Ngoại	Trung bình	BS	KHTH (PĐD phối hợp)
26	22/07	noitq	Chưa trình bệnh cho bác sĩ trực gây thiếu sót chẩn đoán	Nhẹ	ĐD	PĐD
27	22/07	noitq	Xử trí thuốc chỉ dựa vào giấy tờ ban đầu, chưa thăm khám lại đầy đủ	Nhẹ	BS	KHTH (PĐD phối hợp)
28	23/07	noitq	Chỉ định cận lâm sàng chưa phù hợp trên người bệnh suy tim, chậm xử trí khi SpO2 giảm	Nghiêm trọng	ĐD+BS	PĐD + KHTH
29	26/07	nhi	Nhầm lẫn thông tin người bệnh khi báo dịch	Chưa gây hại	ĐD	PĐD
30	05/08	truyennhiem	Chỉ định nhầm loại xét nghiệm dẫn đến thanh toán sai	Nhẹ	BS	KHTH (PĐD phối hợp)
31	09/08	duoc	Phát thuốc hết hạn sử dụng cho người bệnh	Nhẹ	HC	Đơn vị liên

STT	Ngày	Khoa	Sự cố (tóm tắt)	Mức độ	Nhóm	Chủ trì phân tích
						quan
32	10/08	truyennhiem	Sử dụng nhiều thuốc và chẩn đoán chưa chính xác	Nhẹ	BS	KHTH (PĐD phối hợp)
33	10/08	truyennhiem	Chẩn đoán chưa chính xác, sử dụng thuốc nhiều	Nhẹ	BS	KHTH (PĐD phối hợp)
34	10/08	noitq	Sử dụng nhiều thuốc chưa cần thiết trên người bệnh	Nhẹ	BS	KHTH (PĐD phối hợp)
35	19/08	noitq	Thiếu giường bệnh khi tiếp nhận người bệnh mới trong đêm	Nhẹ	HC	Đơn vị liên quan
36	19/08	khambenh	Chỉ định thiếu cận lâm sàng cho khách hàng bảo hiểm nhân thọ	Chưa gây hại	BS	KHTH (PĐD phối hợp)
37	27/08	nhi	Trẻ phản ứng tím tái, khó thở sau y lệnh tiêm thuốc, chuyển viện kịp thời	Nhẹ	ĐD	PĐD
38	30/08	khambenh	Chỉ định nhập khoa điều trị chưa phù hợp	Nhẹ	BS	KHTH (PĐD phối hợp)

Ghi chú: *Mã khoa ghi theo phần mềm NT Nursing. Mức độ ghi theo phân loại trên phần mềm; cần đối chiếu cách phân loại mức độ tổn thương theo Thông tư 43/2018/TT-BYT khi phân tích (Cần xác minh).*

Nơi nhận:
- Ban Giám đốc;
- Phòng KHTH, Phòng QLCL;
- Hội đồng Điều dưỡng;
- Lưu: PĐD.

TRƯỞNG PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG